
PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO (POP) TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE CRÍTICO

INSTITUIÇÃO: Pronto Atendimento Dr. Guido Guida

GESTÃO: Instituto Alpha de Medicina para Saúde

CÓDIGO: POP-URG-001 / **VERSÃO:** 1.0

DATA: 20/02/2026

REVISÃO: 12 meses

ELABORAÇÃO: Diretoria Clínica

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes técnicas, operacionais e legais para o transporte inter-hospitalar de pacientes críticos, garantindo segurança assistencial, continuidade do cuidado e respaldo técnico-jurídico institucional.

2. ABRANGÊNCIA

Aplica-se a médicos, enfermeiros, equipe de remoção e regulação envolvidos no transporte inter-hospitalar.

3. DEFINIÇÃO DE PACIENTE CRÍTICO

Paciente com risco iminente de morte ou instabilidade clínica, incluindo via aérea avançada, uso de drogas vasoativas, instabilidade hemodinâmica ou risco de parada cardiorrespiratória.

4. MODALIDADE DE TRANSPORTE

Ambulância tipo D (UTI móvel), composta obrigatoriamente por médico, enfermeiro e condutor socorrista, com equipamentos de suporte avançado.

5. CRITÉRIOS DE NÃO TRANSPORTE

- Instabilidade hemodinâmica refratária, mesmo com suporte otimizado
- Necessidade de intervenção imediata não disponível durante transporte
- Ventilação mecânica não estabilizada
- Ausência de equipe ou equipamento compatível com a gravidade

6. VEDAÇÃO DE ACOMPANHANTE

A presença de acompanhantes é vedada, considerando que a ambulância configura ambiente assistencial restrito, destinado exclusivamente à equipe de saúde, sendo

contraindicada a presença de terceiros por comprometer a segurança assistencial e a capacidade de intervenção imediata, especialmente diante do risco de parada cardiorrespiratória durante o transporte.

7. CHECKLIST PRÉ-TRANSPORTE

- Via aérea segura, fixada e com cuff testado
- Dois acessos venosos prévios
- Bombas de infusão revisadas
- Monitorização contínua ativa
- Ventilador testado (quando aplicável)
- Drogas de emergência disponíveis
- Baterias de equipamentos verificadas
- Oxigênio calculado para todo trajeto + reserva mínima de 30%

8. FLUXO OPERACIONAL

Estabilização clínica prévia, monitorização contínua, comunicação com unidade de destino e registro completo em prontuário.

9. DECISÃO MÉDICA E PRIORIDADE

A decisão quanto à realização, prioridade e condições do transporte é ato privativo do médico plantonista, baseado em critérios técnicos e avaliação de risco-benefício, podendo ser postergado quando não houver condições seguras.

10. RESPONSABILIDADES

Médico: decisão, indicação e supervisão
Enfermeiro: preparo, monitorização e suporte
Equipe de remoção: execução segura do transporte

11. REGISTRO OBRIGATÓRIO

Deve conter obrigatoriamente: indicação do transporte, condição clínica, avaliação de risco-benefício, orientação e ciência familiar registrada e identificação do médico responsável.

12. INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRANSPORTE

Toda intercorrência deverá ser prontamente manejada e registrada, incluindo descrição do evento, condutas realizadas e resposta clínica do paciente.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este protocolo possui caráter normativo institucional e é de cumprimento obrigatório, estando sujeito à responsabilização ética, técnica e legal em caso de descumprimento.

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.672/2003.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2.048/2002.

COFEN. Resolução nº 588/2018.

WARREN, J. et al. Guidelines for transport of critically ill patients. Critical Care Medicine, 2004.

20 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,



Dr. Gabriel Cardoso Ramalho
Diretoria Clínica
CRM/SP 166.941
Instituto Alpha de Medicina para Saúde

Dr. Gabriel Cardoso Ramalho
Diretor Clínico – Pronto Atendimento Dr. Guido Guida
CRM/SP 166.941